

GLUCOLIT

让糖尿病前期干预 从“看懂”走向“做得到”

AI 驱动的代谢健康干预平台

前沿证据转译 | OGTT / CGM 数据洞察 | 饮食识图 | 情绪陪伴

CLAWHUNT HACKTHON

我们用六个问题，回答一个判断

这到底是不是一门值得做、现在就要做的生意

01

宏观政策

健康中国·老龄化少子化·慢病医保难题

02

市场与竞对

市场规模与竞争格局分析

03

真需求 or 伪需求

用真实数据自我拷问

04

用户画像

从种子用户到泛人群

05

小红书 VOC

两万多条真实评论深度洞察

06

MVP 产品

GLUCOLIT 产品与官网设计

国家把“治未病”写进了顶层设计

预防为主、关口前移，政策红利流向院外生活方式干预

- 慢病致死占比 88%，疾病负担超 70%**

慢病已是国民健康头号威胁
- 《健康中国 2030》**

2030 年实现全人群、全生命周期慢病健康管理
- 《糖尿病防治行动方案 2024–2030》**

把糖尿病防控列为国家专项行动
- 从院内治病 → 院外管理**

生活方式干预成为政策明确方向

88%

慢性非传染性疾病导致的死亡
占全国总死亡人数的比例

>70%

占疾病总负担的比重

老龄化 + 少子化，逼迫慢病防线前移

养老与医疗负担加重，代谢病却在快速年轻化

3.10亿

60 岁以上人口

占总人口 22.0%

15.6%

65 岁以上占比

每 6 人有 1 位老人

954万

2024 出生人口

处于历史低位

≈1.0

总和生育率

全球主要经济体倒数



能干活、能交社保的人越来越少，养老与医疗的担子却越来越重。
VOC 中“24 岁空腹血糖 7.2”“26 岁确诊”并不罕见——糖前期已不再是老年人的专利。

慢病医保做“加减法”，机会留给院外管理

少生病 = 多结余，生活方式干预成为医保体系刚需伙伴



“两病”患者 3 亿+

高血压/糖尿病门诊用药纳入医保，报销 50% 以上



糖尿病医疗支出 ~1090 亿美元

全球第二，并发症费用负担持续攀升



支付改革：按病种付费全覆盖

“结余共享、超支分担”——少生病即多结余



院内控费 → 院外承接

生活方式干预从可选项变成刚需

国际学界也在把干预线前移：《柳叶刀》建议为糖尿病重新分期

2026 年 1 月《柳叶刀》子刊评论——四位国际内分泌学家联合呼吁，重构“糖前期”认知

① 为什么建议废除“糖前期”这个名称？



低估风险

把“前期”误读为“还没生病”；此阶段血糖异常已抬高心血管、慢性肾病乃至认知损害风险



延误干预

名称太“温柔”，医患都易松懈，错过最佳干预窗口



诊疗空白

多种有效干预（含药物）尚未获批用于“前期”，需要的人难及时获得

② 新的分期思路

把 2 型糖尿病看作一个连续发展的过程——像肿瘤分期一样分为三期，让干预时间线整体前移。

1 期

正常血糖高风险期

血糖仍在正常范围，胰岛功能可能已出现轻微变化



2 期

代谢损伤进展期

血糖异常持续、代谢负担逐步累积



3 期

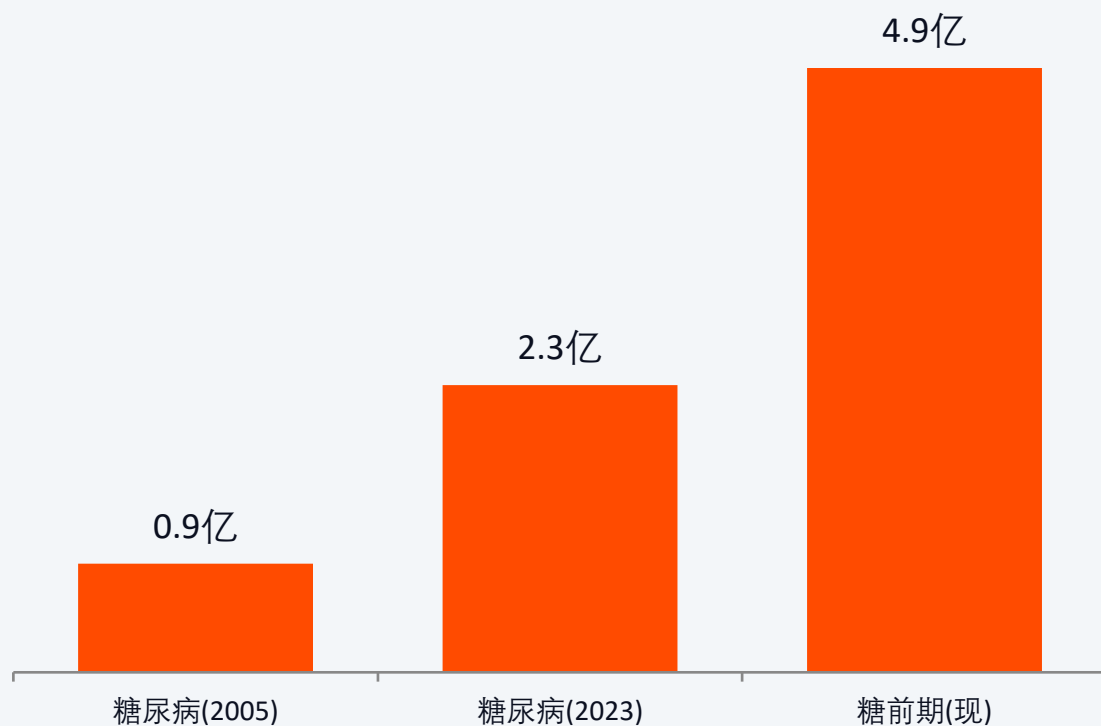
临床糖尿病期

进展为 2 型糖尿病，并发症风险上升

对 GLUCOLIT 的意义：国际学界与国家“关口前移”同向——把干预窗口整体前移，正是 GLUCOLIT“代谢风险连续管理”定位的循证注脚；我们提供健康教育与行为支持，不做诊断与疗效承诺。

一个被严重低估的“上游”市场

糖前期：最大、最可逆、却最少被认真服务的人群



35.2%

成人糖尿病前期患病率（ADA 标准），约 4.9 亿人

43.3%

糖尿病知晓率——超半数人不知情

最少被服务

糖前期 = 最大、最可逆、供给最空白的人群

赛道拥挤，但“整合闭环”仍是空位

每一家只做了链条里的一段



综合健康 App

Keep / 薄荷健康

流量大，但糖前不专业



控糖训练营 / 微商

社群 + 打卡

门槛低，信任差、无长期反馈



医院内分泌科

三甲权威

权威，却不管日常执行



CGM 硬件厂商

雅培 / 硅基 / 鱼跃

有数据，缺解读与陪伴



海外数字疗法

Virta / Levels / Omada

已验证有效，未本土化



司美格鲁肽

GLP-1 药物

见效快，需配套、停药反弹

GLUCOLIT 的空位：把“可信证据 + 多模态识别 + 指标解读 + 情绪陪伴”放进同一连续闭环，并做本土合规。

先自我拷问：真需求，还是伪需求？

需求是真的，但入口必须换一个

反方 · 是伪需求（我们自己的验证）

- 恐惧型内容 28,806 曝光；方案型仅 284 曝光、0 转化
- “用户愿意一起害怕，不愿意一起付费”
- 治愈悖论：逆转即流失，LTV 天花板极低
- “逆转都是骗人的”（204 赞）= 信任雷区

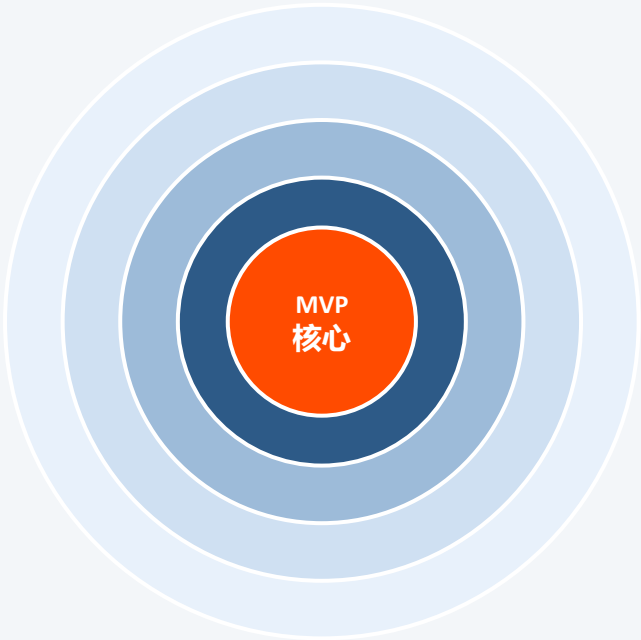
正方 · 是真需求（20,437 条去重评论再分析）

- 第一需求：判断是否危险、指标怎么看、下一步做什么
- 最高频痛点：医生沟通、每天怎么吃、诊断困惑、运动执行
- 用户已在为 CGM / 私教 / 营养师 / 中医付费
- 缺的不是内容，是可信的筛选、解释与行动翻译

结论：这不是“逆转话术”市场，而是“代谢风险管理”市场——卖“执行 + 反馈 + 陪伴 + 避坑”。

MVP 首发人群：从 4.9 亿收敛到最锋利的核心圈

不服务“所有糖前期”，先服务最该被服务、也最可能留下来的人



核心圈 ≈ 500–900 万人（量级估算）

收敛逻辑与规模（自上而下逐层筛选）

糖前期成人总盘	约 4.9 亿
30–50 岁 · 坏习惯已积累、数字化可触达	约 1.5 亿
已确诊 / 已知糖前 · 教育成本低	约 3,000 万
健康意识强 · 主动想改变	约 1,300 万
想改变却缺自律、缺方法 = 核心圈	约 500–900 万

获客渠道（按意向强度） ① 体检机构检后随访：报告箭头亮起即最强触点 ② CGM / 血糖仪厂商用户导流 ③ 内容平台精准截流：指标解读 · 怎么吃 ④ 内分泌科 / 药企依从性管理转介

来源：规模为“公开患病率×分层假设”的量级估算，非精确统计；分层仅代表MVP 首发优先级，不构成人群价值判断或疗效承诺

用户不是单一人群，而是一条连续谱

从焦虑筛查到家庭照护，产品入口按分层递进

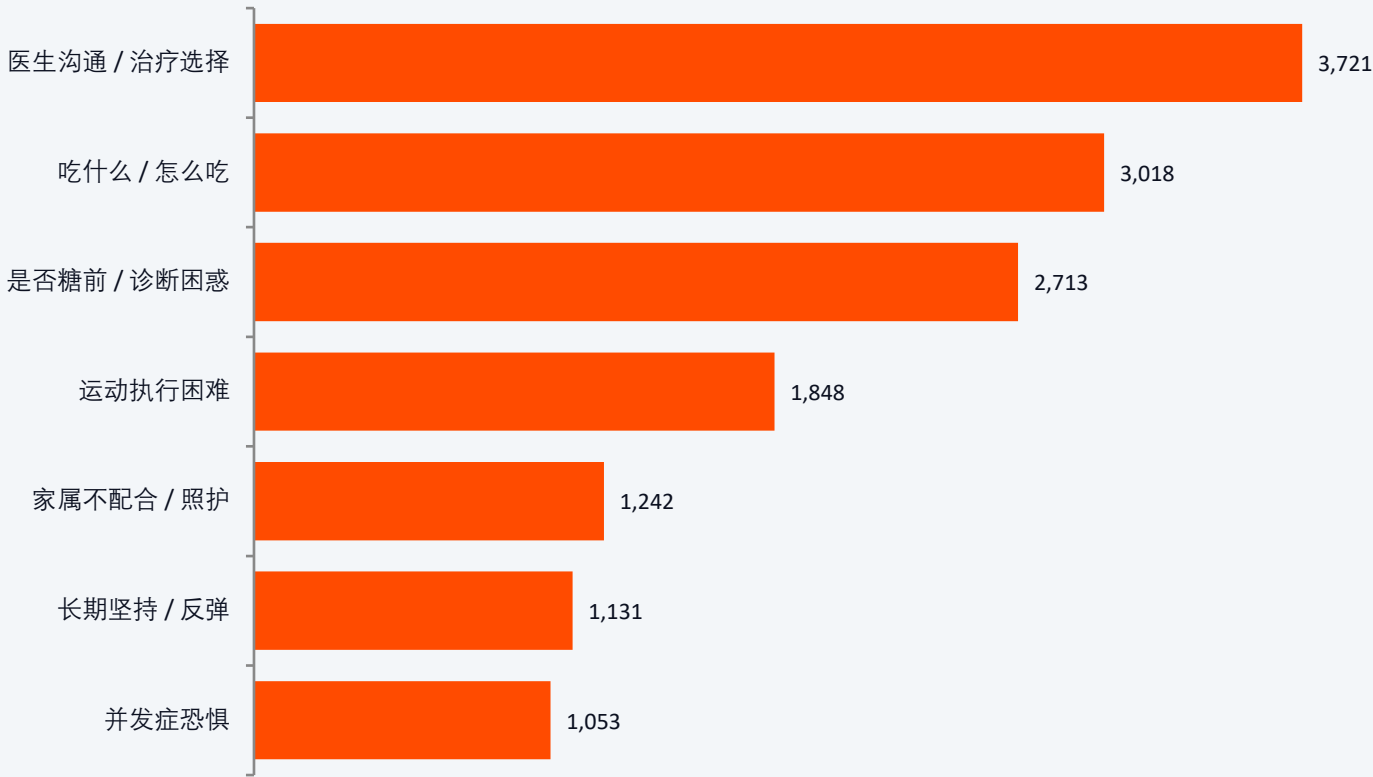
年轻糖前期焦虑者 奶茶 / 熬夜 / 饭后困，不敢查 产品入口 轻量筛查与入门教育	已检测异常实操者 空腹 / 餐二 / 糖化 / 动态血糖都在问 产品入口 餐食复盘与指标解读	胰岛素抵抗·多囊 多囊 / 脂肪肝 / 血脂，瘦型也抵抗 产品入口 专项方案与周期追踪	家属照护者 父母不听劝、偷吃、并发症恐惧 产品入口 家庭共管与沟通脚本	数据监测型用户 用血糖仪测食物与运动反应 产品入口 食物反应实验与报告
--	---	--	--	--

扩散路径：从高压白领种子人群，扩到实操者与家属照护，再到 4.9 亿泛糖前期与“体检有箭头”的泛代谢人群。

小红书 VOC：两万多条评论说了什么

旧样本确认“执行难”，新增样本进一步指向“辨别难”

痛点优先级（信号强度）



新增 3,262 条的最强信号

指标困惑	1814
信任 · 伪科学	982
药物 · 干细胞	947
减肥 · 40+ 女性	946
低碳 / 生酮争议	851

信息污染在抢用户注意力：

极端方案与伪科学话术流行，用户从“执行难”转向“辨别难”——缺的是可信筛选、解释与避坑。

MECE 需求树：四层递进，不能跳级

入口从低门槛评估起步，再进入执行陪跑与长期维持



关键洞察：直接售卖“保证逆转”触发不信任；先给可信评估与指标解读，再谈陪跑。

付费逻辑：为“确定性”而非“课程”付费

为省心、确定性、陪伴、复盘与避坑付费。

已付费 56 · 愿付费 31（评论区天然低估）；CGM 92 提及 / 私教 / 营养师 / 中医。

产品接受度 · 四象限

高认可 · 高需求	血糖仪 / 动态血糖 / 低 GI 主食 / 高蛋白零食
高需求 · 需教育	陪跑营 / 指标解读 / 餐食复盘 / 家庭共管 / 运动处方
有争议 · 需谨慎	保健品 / 苹果醋 / 益生菌 / 降糖茶 / 断食生酮
低信任 · 高风险	保证逆转 / 神药 / 干细胞营销 / 无证医学承诺

糖前期最难的，不是知道要健康

而是把一次异常指标，变成长期可持续的日常行动

01 看不懂

报告里有血糖、胰岛素、HbA1c，用户不知道异常意味着什么

02 不会选

网络信息碎片化，科普、营销与个体建议混在一起

03 做不久

饮食、运动、睡眠与情绪改变需要持续反馈，而不是一次提醒

GLUCOLIT：一个围绕“理解—行动—反馈”的 AI 闭环

不是替代医生，而是把专业证据转成用户每天能执行的一小步



五项能力共同服务一个目标：降低认知负担，提高持续行动概率。

能力详解（上）：看懂证据 → 理解指标

① 前沿科普转译 + ② OGTT 报告解读



① 看懂证据 | 前沿科普转译

把顶级研究翻译成能懂、能做的中文行动

- 聚合糖前、胰岛素抵抗、饮食与 CGM 证据
- 重写为：结论、适用人群、行动清单、风险边界
- 保留 DOI / PubMed 溯源，避免“AI 说了算”



② 理解指标 | OGTT 报告一键识别

截图识别+ 人工校对+ 规则判断

- 不只看 2 小时血糖，同时理解空腹、1h、2h、胰岛素与 HbA1c
- 先校对再分析，降低 OCR 错读导致错误结论
- 输出：指标解读、风险提示、生活干预、复查建议

能力详解（下）：理解指标 → 识别当下

② CGM 连续曲线洞察 + ③ 饮食拍照识图



② 理解指标 | CGM 连续曲线洞察

把连续曲线变成个人化学习反馈

- 餐后峰值：哪类食物让曲线上升更快
- 波动幅度：同样碳水在不同时间的反应
- 恢复速度：餐后活动与睡眠是否影响回落（短期学习工具，不制造焦虑）



③ 识别当下 | 饮食拍照识图

不是报热量，而是帮你做更好的下一次选择

- 识别：主要食物、烹饪方式、估计份量
- 评估：碳水化合物密度、蛋白、膳食纤维、蔬菜比例
- 建议：进餐顺序、替换方案、份量与餐后活动

核心 AI | 情绪陪伴教练：在最易放弃那一刻接住用户

每日签到、即时陪伴、重新开始计划与每周复盘

“我快坚持不住了”

三分钟稳住当下，把目标缩小

偏离后重新开始

不羞耻、不清零，从下一餐开始

危机安全分流

识别自伤风险，优先引导真人与急救支持

真正的护城河：理解“知道但做不到”的人性阻力。

一个用户的一天：GLUCOLIT 把碎片动作连成闭环

每一次输入，都为下一次更精准的建议积累上下文



结果不是一次“诊断”，而是持续增强的健康自我效能

GLUCOLIT 官网：第一步就能开始

降低启动门槛，把信任设计写在首页



信任设计：证据透明可查（DOI/PubMed）· 上传结果可校对 · 危机安全分流 · 不做诊断或疗效承诺

为什么是 GLUCOLIT?

用“可信证据 + 多模态 AI + 行为陪伴”形成差异化

传统科普

信息正确，但离个人行动很远

单点 AI 工具

能回答一次，但缺少长期上下文

GLUCOLIT

看懂数据 · 给出行动 · 陪伴坚持（连续行为闭环）

商业化路径： 个人订阅 → 企业健康管理 → 体检 / 营养 / 互联网医疗合作。

现在，我们要把“能用”推到“被持续使用”

下一步路线图与合规底线

01

产品验证

完成首批糖前期用户 4-8 周行为留存测试



02

数据接入

接入 CGM 报告/API，建立个人反应画像



03

生态合作

连接体检、营养师与生活方式医学服务

让每一个糖前期用户，都拥有一个懂数据、懂生活、也懂坚持的 AI 同行者。

依据：CDC National DPP；产品定位为健康教育与行为支持，不替代诊断和治疗。



让每一个糖前期用户，
都拥有一个懂数据、懂生活，也懂坚持的 AI 同行者。

GLUCOLIT